肝肾同源理论指导下的甲状腺疾病诊疗研究

——基于精血同源与阴阳互根视角的现代诠释

摘要：肝肾同源（乙癸同源）是中医学阐述肝肾两脏生理相关、病理互累的核心理论，其内涵涵盖精血同源、阴阳互根、藏泄互用等方面。本文在传统理论基础上，结合现代内分泌学认识，将肾定义为生长发育及血液化生相关激素的总调节器（肾藏精，主生长化收藏），将肝定义为血液调节与内环境稳态的调节器（肝藏血，主疏泄），系统探讨肝肾同源理论在甲状腺疾病诊疗中的应用价值。通过对甲状腺功能亢进症、甲状腺功能减退症、桥本甲状腺炎、甲状腺结节等常见甲状腺疾病的分析，揭示其病机演变均与肝肾阴阳失衡密切相关：甲亢期多属“水不涵木、肝阳上亢”，甲减期多属“阴损及阳、精血两虚”，结节类病变则涉及“气郁、痰凝、血瘀”互结而根本在肝肾。在治疗上，提出以滋水涵木、滋阴潜阳、温肾助阳、养血疏肝等法调节肝肾阴阳，使精血互生、阴阳互济，恢复甲状腺的正常功能。本文整合文献研究、理论探讨与临床经验，构建以肝肾同源为核心的甲状腺疾病辨治体系，以期为甲状腺疾病的中医诊疗提供新的理论视角与实践指导。

关键词：肝肾同源；乙癸同源；精血同源；阴阳互根；甲状腺疾病；甲状腺功能亢进症；桥本甲状腺炎；甲状腺结节

---

1 引言

甲状腺疾病是临床常见的内分泌代谢疾病，包括甲状腺功能亢进症（甲亢）、甲状腺功能减退症（甲减）、桥本甲状腺炎（HT）、甲状腺结节等。近年来，随着生活节奏加快、情志压力增大以及检测技术的普及，甲状腺疾病的发病率呈持续上升趋势，女性患者尤为多见。现代医学对甲状腺疾病的治疗以激素替代、抗甲状腺药物、放射性碘及手术为主，虽能一定程度控制病情，但仍存在复发率高、副作用明显、部分患者疗效不佳等问题。

中医学将甲状腺疾病归属于“瘿病”“瘿瘤”“气瘿”等范畴，历代医家积累了丰富的诊疗经验。从病位来看，甲状腺位于颈前喉结两侧，属肝经所过之处，与肝的关系最为密切；从病机来看，气滞、痰凝、血瘀互结是甲状腺结节类病变的基本病理，而气机郁滞首责于肝。然而，甲状腺作为内分泌腺体，其功能活动与人体生长发育、物质代谢密切相关，这些功能在中医学理论体系中归属于肾所主的“生长化收藏”范畴。因此，甲状腺疾病的病机演变实为肝、肾两脏功能失调的综合体现。

“肝肾同源”理论源于《黄帝内经》，历经后世医家阐发，成为中医学脏腑相关理论的核心内容之一。其内涵包括“精血同源”——肝藏血，肾藏精，精血互生；“阴阳互根”——肾阴为一身阴液之本，肝阴赖肾阴滋养，肝肾之阳相互为用；“藏泄互用”——肝主疏泄，肾主封藏，二者相反相成。这些理论为认识甲状腺疾病的发生发展规律提供了独特视角。

值得深思的是，如何将传统“肝肾同源”理论与现代内分泌学认识相结合？本文尝试在保持中医理论特质的前提下，进行适度的现代诠释：将肾定义为生长发育及血液化生相关激素的总调节器，涵盖下丘脑-垂体-甲状腺轴、下丘脑-垂体-

性腺轴等神经内分泌功能，体现“肾藏精，主生长化收藏”的内涵；将肝定义为血液调节与内环境稳态的调节器，涉及血流分配、物质代谢、神经-内分泌-免疫网络的稳态维持，体现“肝藏血，主疏泄”的功能。这一诠释旨在搭建传统理论与现代医学的对话桥梁，为甲状腺疾病的诊疗提供更具整合性的思路。

本文将从肝肾同源的理论内涵入手，系统分析甲状腺疾病与肝肾两脏的内在联系，探讨基于肝肾同源理论的诊疗策略，并结合现代研究进展，展望该理论指导甲状腺疾病防治的应用前景。

---

2 肝肾同源的理论内涵与现代诠释

2.1 肝肾同源的经典理论渊源

“肝肾同源”又称“乙癸同源”，其理论渊源可溯至《黄帝内经》。《素问·阴阳应象大论》云：“肾生骨髓，髓生肝”，首次揭示了肝肾两脏的母子相生关系。至金元时期，医家李杲在《医学发明》中明确提出“肝肾同源”之说。明代李中梓在《医宗必读》中系统阐发“乙癸同源”理论，指出“肾肝同治者，肾水也，肝木也，木无水的则干，水无木则竭”，奠定了肝肾同治的理论基础。

肝肾同源的理论内涵主要包括三个层面：

其一，**精血同源**。肝藏血，肾藏精，精血之间相互资生、相互转化。肾精化生肝血，使肝有所藏、体阴得充；肝血滋养肾精，使肾精不竭、封藏有度。正如

《张氏医通》所言："精不泄，归精于肝而化清血。"精血同源构成肝肾两脏物质基础的内在统一。

其二，**阴阳互根**。肾阴为"元阴"，是一身阴液之本，涵养肝阴使肝阳不亢；肾阳为"元阳"，是一身阳气之根，温煦肝脉使肝用得行。同时，肝之阴血又可下充肾精，助肾阴之化生；肝之阳气疏泄有度，有助于肾阳的布达。肝肾阴阳相互依存、相互为用，形成动态平衡。

其三，**藏泄互用**。肾主封藏，肝主疏泄，二者相反相成。肝之疏泄调节肾之开阖，使精泄有度；肾之封藏制约肝之疏泄，使疏泄不过。藏泄互用维持着生殖、代谢等功能的正常进行。

2.2 基于神经-内分泌-免疫网络的现代诠释

从现代生物学视角审视，肝肾同源理论蕴含着深刻的科学内涵。本文尝试在尊重中医理论特质的前提下，结合现代内分泌学认识，对肝肾功能进行功能性定义：

肾——生长发育及血液化生相关激素的总调节器

肾所主的"藏精""主生长化收藏"功能，在宏观层面体现为机体的生长、发育、生殖、衰老过程，在微观层面则与神经内分泌系统的调控功能高度相关。具体而言，下丘脑-垂体-甲状腺轴、下丘脑-垂体-性腺轴、下丘脑-垂体-肾上腺轴的功能状态，均可视为"肾"功能的体现。这些轴系通过激素分泌的反馈调节，维持着机体的生长、发育、代谢稳态。甲状腺作为下丘脑-垂体-甲状腺轴的效应器

官，其激素分泌调控、靶组织反应性，均与“肾”的功能状态密切相关。此外，促红细胞生成素（EPO）、血小板生成素（TPO）等调控血液化生的激素，亦可纳入“肾”主血液化生的功能范畴。

肝——血液调节与内环境稳态的调节器

肝所主的“藏血”“主疏泄”功能，在宏观层面体现为情绪调节、气血运行、消化吸收等，在微观层面则与血流分配、物质代谢、神经-内分泌-免疫网络的稳态维持密切相关。肝脏作为机体最大的代谢器官，参与糖、脂、蛋白质的代谢调控；肝血窦内皮细胞构成的血-肝屏障，选择性摄取、代谢、清除内源性和外源性物质；枯否细胞等免疫细胞构成肝脏免疫监视功能。这些功能可视为“肝藏血”的现代体现。而“肝主疏泄”则涉及神经递质、激素、细胞因子等信号分子的释放与调节，维持着内环境的动态平衡。

基于上述诠释，肝肾关系在神经-内分泌-免疫网络层面呈现出多重联系：下丘脑-垂体-甲状腺轴与肝脏代谢功能相互影响；甲状腺激素调控肝脏代谢酶活性；肝脏合成的甲状腺激素结合球蛋白（TBG）影响甲状腺激素的运输与代谢；炎症因子介导的神经-免疫-内分泌网络将肝肾两脏紧密联系。这些现代认识为“肝肾同源”理论提供了新的证据支撑。

2.3 肝肾调节功能与甲状腺的生理联系

甲状腺作为重要的内分泌腺体，其功能活动与肝肾两脏存在多层次联系：

从胚胎发育看，甲状腺滤泡细胞起源于内胚层，但甲状腺 C 细胞起源于神经嵴，与神经系统的发育同源，这一发育学事实与“肾主骨生髓，髓生肝”的经典论述形成有趣呼应。

从物质代谢看，甲状腺激素的合成需要酪氨酸和碘，前者是蛋白质代谢的产物，与肝的蛋白质合成功能相关；后者经胃肠道吸收后，由肝脏参与代谢转化。甲状腺激素的靶组织遍及全身，肝脏是其主要作用靶点之一，调控肝细胞的糖、脂、蛋白质代谢。同时，肝脏合成的甲状腺激素结合球蛋白（TBG）、白蛋白等，影响血液中甲状腺激素的运输与生物利用度。

从功能调控看，下丘脑-垂体-甲状腺轴的反馈调节，与“肾主生长化收藏”所涵盖的生长调控功能相吻合；甲状腺激素对全身组织代谢的促进作用，则为肝的疏泄功能提供能量基础。因此，甲状腺可视为肝肾协同调控网络中的重要节点，其功能状态既是肾功能（生长调控）的体现，也影响肝功能的发挥。

---

3 甲状腺疾病与肝肾两脏的相关性分析

3.1 甲状腺疾病的中医病名归属与病位认识

甲状腺疾病在中医学中主要归属于“瘿病”范畴。瘿病之名首见于《山海经》，指颈前喉结两侧肿大的一类疾病。依据病因病机及临床表现的不同，又有“气瘿”“肉瘿”“石瘿”“瘿瘤”等区分。从病位来看，颈前属任脉所过，但喉结两侧为肝

经所循，故《医宗金鉴》指出“瘿瘤二证，发于皮肤血肉筋骨之处，其原由肝经抑郁所致”。现代医家多认为甲状腺疾病病位主要在肝，涉及脾、肾。

然而，深入分析不同甲状腺疾病的病机特点，可以发现肝肾两脏在疾病发生发展中起着核心作用。甲状腺功能亢进症以高代谢症候群为主要表现，临床见心悸、手颤、烦躁、多汗、多食易饥、消瘦等，其病机以阴虚阳亢、虚火内扰为主，根本在于肝肾阴虚、水不涵木。甲状腺功能减退症以低代谢症候群为主要表现，临床见乏力、畏寒、水肿、反应迟钝、便秘等，其病机以阳气虚衰、精血不足为主，涉及肾阳虚衰、肝血亏虚。桥本甲状腺炎作为自身免疫性甲状腺炎，其病程演变呈现从甲亢到甲减的动态过程，早期多属肝郁化火、肝阳上亢，后期则以脾肾阳虚、精血两虚为主。甲状腺结节则涉及气郁、痰凝、血瘀互结于颈前，病虽在局部，根在肝脾肾三脏功能失调。

3.2 从肝肾角度解读甲状腺疾病的病因病机

3.2.1 甲亢——“水不涵木，肝阳上亢”

甲状腺功能亢进症（甲亢）以甲状腺激素分泌过多为病理基础，临床表现为高代谢症候群及交感神经兴奋症状。从中医视角审视，其病机可概括为“阴虚阳亢”——阴虚为本，阳亢为标。阴之所指，主要是肝肾之阴；阳之所指，主要是肝阳。

肾阴为一身阴液之本，涵养肝阴使肝阳不亢。若先天禀赋不足、劳倦内伤、久病耗损，或情志过极、郁而化火，暗耗肝肾之阴，则致水不涵木——肾水不足以滋养肝木，肝阴亏虚，阴不制阳，肝阳上亢。肝阳上亢则见烦躁易怒、头痛

眩晕；肝阳化风则见手颤舌颤；肝火上炎则见目赤口干；虚火扰心则见心悸失眠；肝火犯胃则见多食易饥。诚如《临证指南医案》所言："肝为风木之脏，体阴用阳，其性刚，主动主升，全赖肾水以涵之，血液以濡之。"甲亢的种种表现，正是肝失濡养、阳亢风动的集中体现。

从现代诠释角度理解：肾作为生长发育相关激素的总调节器，涉及下丘脑-垂体-甲状腺轴的功能状态。甲亢时负反馈调节受损，可视为"肾"的调控功能失常。肝作为内环境稳态调节器，在甲亢状态下表现为代谢亢进、神经兴奋性增高等"疏泄太过"之象，其本质则是"体阴"不足——肝血肝阴亏虚，不足以涵养"用阳"。

3.2.2 甲减——"阴损及阳，精血两虚"

甲状腺功能减退症（甲减）以甲状腺激素分泌减少为病理基础，临床表现为低代谢症候群及多系统功能低下。从中医病机看，甲减多由甲亢迁延、治疗失当，或自身免疫损伤、甲状腺手术、放射性碘治疗等因素所致，呈现"阴损及阳、精血两虚"的演变规律。

阴损及阳：甲亢阶段以阴虚阳亢为主，持续发展则阴液日亏，无以化气，阴损及阳，渐至阳虚。肾阳为一身阳气之根，肾阳虚衰则温煦失职，见畏寒肢冷、腰膝酸软；气化失司，水湿内停，见水肿尿少；推动无力，见神疲乏力、反应迟钝。肝阳虚则疏泄不及，气血运行迟滞，见情绪低落、胸闷胁痛。

精血两虚：肾藏精，肝藏血，精血互生。甲亢久延，耗伤肝肾之阴，精血暗耗；及至甲减阶段，精血亏虚之象毕现。肾精不足则髓海空虚，见头晕耳鸣、记忆

力减退；肝血亏虚则筋脉失养，见肢体麻木、爪甲枯脆；血不养心则心悸怔忡；血不荣面则面色苍白。

桥本甲状腺炎合并甲减的病机更为复杂，除上述精血两虚、阳气虚衰外，还涉及气滞、痰凝、血瘀等病理产物。张珊珊等认为，桥本甲状腺炎属肝脾肾三脏同病，肾虚贯穿全程，阳虚是主要结局。陈如泉教授亦强调，肝脾肾功能失调是本病发生发展的主要因素。

3.2.3 桥本甲状腺炎——从肝郁到肾虚的动态演变

桥本甲状腺炎（HT）是最常见的自身免疫性甲状腺疾病，其病理特征为甲状腺内淋巴细胞浸润、滤泡破坏，最终多发展为甲减。HT 的病程演变呈现动态变化，早期可表现为甲亢，后期则转为甲减。这一演变过程与肝肾两脏的阴阳转化密切相关。

早期（甲亢期）：多因情志不遂，肝气郁结，郁而化火，肝火上炎；或素体阴虚，水不涵木，肝阳上亢。病机以肝郁化火、肝阳上亢为主，证见烦躁易怒、心悸手颤、多食易饥、消瘦乏力。此时病位主要在肝，涉及肾阴不足。

中期（波动期）：病情迁延，肝火耗伤阴血，肝病及脾，肝郁脾虚，痰气交阻。证见颈前肿大、胸闷胁痛、神疲乏力、大便不调。病位在肝脾，涉及肾阴渐损。

后期（甲减期）：阴损及阳，精血两虚，脾肾阳虚。证见畏寒肢冷、神疲乏力、面浮肢肿、腰膝酸软。病位在脾肾，涉及肝血亏虚。

柳红芳教授总结 HT 的病机演变规律，指出甲亢期以“水不涵木、肝阳上亢”为主，甲减期以“阴损及阳、精血两虚”为主，早期治以滋水涵木、清肝泻火，后期治以滋阴养血、温肾助阳。这一认识深刻揭示了肝肾在 HT 发病中的核心地位。

3.2.4 甲状腺结节——气痰瘀互结，根本在肝肾

甲状腺结节是临床常见病，女性发病率远高于男性。多数结节为良性，但部分有恶变风险。中医认为，结节的形成与气滞、痰凝、血瘀密切相关，三者互结于颈前而形成有形之邪。

气滞之因在于肝：肝主疏泄，调畅全身气机。情志抑郁、恼怒伤肝，致肝气郁结，气机不畅，津液输布失常，血行迟滞，遂生痰瘀。痰凝之因在脾与肾：脾主运化水湿，肾主水液代谢。肝郁乘脾，脾失健运，水湿内停，聚而为痰；肾阳不足，气化失司，水湿不运，亦可生痰。血瘀之因在肝与心：肝藏血，主疏泄，肝气郁结则血行不畅；心主血脉，肾精化血，精血亏虚则脉道不充，血行迟滞。

虽然结节形成涉及气痰瘀互结，但其根本在于肝肾阴阳失调。肝郁是启动因素，但郁久必耗伤肝阴；肾阴是肝阴的根本，肝阴亏虚必然下汲肾阴；阴损及阳，终致阴阳两虚。张毅等指出，甲状腺结节基本病位在肝、脾、肾，治疗应在分清主次的基础上三脏同调。从肝肾同源角度审视，疏肝不忘养肝，养肝必及滋肾，方能使气血调和、结节得消。

3.3 甲状腺疾病临床分期与肝肾阴阳演变规律

综合上述分析，甲状腺疾病的临床演变呈现规律性的肝肾阴阳转化过程。下表概括了常见甲状腺疾病不同阶段的病机特点：

疾病类型	分期/阶段	核心病机	肝肾病理	临床表现特点
甲亢	初发期	阴虚阳亢	水不涵木，肝阳上亢	心悸手颤、烦躁易怒、多食易饥
甲亢	迁延期	气阴两虚	肝阴亏虚，肾精暗耗	乏力、消瘦、心悸、盗汗
桥本甲状腺炎	甲亢期	肝郁化火/肝阳上亢	肝火亢盛，肾阴不足	烦躁、手颤、颈部不适
桥本甲状腺炎	甲减期	精血两虚，脾肾阳虚	阴损及阳，精血亏虚	畏寒、乏力、水肿、记忆力减退
甲减	早中期	阳气亏虚	肾阳虚衰，肝血不足	畏寒乏力、面色苍白、腰膝酸软
甲减	重症期	阴阳两虚	精血枯竭，阴阳俱损	极度乏力、水肿、反应迟钝
甲状腺	初期	气郁痰凝	肝气郁结	颈部结块、情绪抑

疾病类型	分期/阶段	核心病机	肝肾病理	临床表现特点
结节				郁
甲状腺结节	后期	痰瘀互结	肝郁脾虚，肾阳不足	结节增大、质地变硬

由上表可见，无论是甲亢、甲减还是桥本甲状腺炎，其病机演变均围绕肝肾阴阳消长展开。甲亢以阴虚阳亢为主，甲减以阳虚精亏为主，桥本甲状腺炎则呈现从肝郁火旺到阴虚阳亢再到精血两虚的完整演变链。这一规律为临床分期论治提供了理论依据。

---

4 基于肝肾同源的甲状腺疾病诊疗策略

4.1 诊疗基本原则：燮理肝肾，调和阴阳

基于上述病机分析，甲状腺疾病的治疗应遵循“燮理肝肾、调和阴阳”的基本原则。具体而言，包括以下几个方面：

治病求本，本于阴阳。甲状腺疾病虽有局部表现，其根本在于全身阴阳失衡。甲亢之本是阴虚，甲减之本是阳虚，桥本甲状腺炎则经历从阴虚到阳虚的动态演变。治疗当以调节阴阳为第一要义，阴平阳秘，精神乃治。

肝肾同治，各有侧重。肝肾同源决定了二者在病理上相互影响、在治疗上相互为用。治肝不忘补肾，滋水即以涵木；治肾不忘疏肝，疏肝有助于肾气的布达。但不同阶段应有侧重：甲亢期重在滋水涵木、平肝潜阳；甲减期重在温肾助阳、养血益精；结节类病变则疏肝理气与补肾软坚并施。

精血互生，阴阳互济。精血同源意味着补血必先填精，填精必赖养血；阴阳互根意味着补阳当于阴中求，滋阴当于阳中求。在组方用药时，当遵循“善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷；善补阴者，必于阳中求阴，则阴得阳升而泉源不竭”的原则。

4.2 分型论治方案

4.2.1 甲亢的肝肾分型治疗

甲亢的治疗以滋阴潜阳为总则，具体分以下证型：

肝火亢盛、肾阴亏虚证：证见烦躁易怒、面红目赤、心悸手颤、口干口苦、多食易饥、舌红苔黄、脉弦数。治以清肝泻火、滋阴潜阳，方选龙胆泻肝汤合知柏地黄丸加减。常用药：龙胆草、栀子、黄芩清肝泻火；生地黄、知母、黄柏滋肾泻火；夏枯草、浙贝母清肝散结；牡蛎、龙骨平肝潜阳。

阴虚阳亢、水不涵木证：证见头晕目眩、心悸不宁、手颤舌颤、腰膝酸软、失眠多梦、舌红少苔、脉细数。治以滋水涵木、平肝潜阳，方选一贯煎合镇肝熄风汤加减。常用药：生地黄、熟地黄、枸杞子滋肾养肝；麦冬、沙参养阴生津；白芍、当归养血柔肝；龟板、鳖甲、牡蛎滋阴潜阳；钩藤、天麻平肝熄风。

气阴两虚、余邪未清证：多见于甲亢迁延或治疗后，证见神疲乏力、心悸气短、自汗盗汗、咽干口燥、舌红少津、脉虚数。治以益气养阴、清泻余邪，方选生脉散合六味地黄丸加减。常用药：太子参、麦冬、五味子益气养阴；生地黄、山茱萸、山药滋肾填精；玄参、浙贝母养阴散结；牡丹皮、地骨皮清虚热。

现代研究表明，滋水涵木法治疗甲亢在提高有效率、降低复发率、改善并发症方面优势显著，其机制可能与调整代谢紊乱、降低炎症水平、提高免疫功能有关。

4.2.2 甲减的肝肾分型治疗

甲减的治疗以温阳益精为总则，具体分以下证型：

肾阳虚衰证：证见畏寒肢冷、腰膝酸软、面浮肢肿、神疲乏力、小便清长、大便溏薄、舌淡胖苔白、脉沉迟。治以温补肾阳、化气行水，方选右归丸合真武汤加减。常用药：附子、肉桂温补肾阳；熟地黄、山茱萸、枸杞子滋肾填精；茯苓、白术、泽泻健脾利水；白芍柔肝敛阴。

肝血亏虚证：证见头晕眼花、面色苍白、爪甲不荣、肢体麻木、月经量少、舌淡苔白、脉弦细。治以养血柔肝、滋肾填精，方选四物汤合左归丸加减。常用

药：当归、熟地黄、白芍、川芎养血和血；枸杞子、菟丝子、鹿角胶滋肾填精；何首乌、阿胶补血益精。

阴阳两虚证：多见于重症甲减或病程日久者，证见形寒肢冷、腰膝酸软、头晕耳鸣、失眠多梦、舌淡少津、脉沉细。治以阴阳双补、益精养血，方选地黄饮子加减。常用药：熟地黄、山茱萸、肉苁蓉、巴戟天滋肾填精；附子、肉桂温补肾阳；石斛、麦冬养阴生津；远志、石菖蒲开窍醒神。

4.2.3 桥本甲状腺炎的分期论治

桥本甲状腺炎应结合病程分期、甲状腺功能状态进行动态论治：

早期（甲亢期）：证见烦躁易怒、心悸手颤、多食易饥、消瘦乏力、颈部不适、舌红苔黄、脉弦数。病机为肝郁化火、肝阳上亢，兼有肾阴不足。治以滋水涵木、清肝泻火。方选丹栀逍遥散合杞菊地黄丸加减。常用药：牡丹皮、栀子清肝泻火；柴胡、白芍疏肝柔肝；生地黄、山茱萸、枸杞子滋肾养肝；夏枯草、浙贝母清肝散结；牡蛎、龙骨平肝潜阳。柳红芳教授主张早期联合外用“结甲平”以增强消癥散结之效。

中期（功能波动期）：证见颈部肿大、胸闷胁痛、神疲乏力、情绪抑郁、食欲不振、大便不调、舌淡苔白腻、脉弦滑。病机为肝郁脾虚、痰气交阻，兼有肾精暗耗。治以疏肝健脾、化痰散结、兼滋肾精。方选逍遥散合二陈汤加减。常用药：柴胡、白芍疏肝柔肝；当归养血和血；茯苓、白术健脾祛湿；陈皮、半夏理气化痰；浙贝母、夏枯草化痰散结；枸杞子、菟丝子平补肝肾。

后期（甲减期）：证见畏寒肢冷、神疲乏力、面浮肢肿、腰膝酸软、记忆力减退、性欲减退、舌淡胖苔白、脉沉细。病机为脾肾阳虚、精血两虚。治以温肾助阳、滋阴养血、扶正固本。方选右归丸合八珍汤加减。常用药：附子、肉桂、鹿角胶温补肾阳；熟地黄、山茱萸、枸杞子滋肾填精；当归、白芍、川芎养血和血；党参、茯苓、白术健脾益气；黄芪、阿胶补益气血。

陈如泉教授治疗桥本甲状腺炎合并甲减，主张肝、脾、肾同治，坚持病证结合，阳虚甚者重用温阳之品，同时兼顾滋阴养血，使阳得阴助而生化无穷。刘怀珍教授基于“滋水涵木扶土”之论，提出以“调肝健脾益肾”为大法，兼顾理气化痰活血。

4.2.4 甲状腺结节的肝肾治疗

甲状腺结节的治疗应以理气化痰、活血散结为标，调补肝肾为本，具体分以下证型：

肝郁气滞证：多见于结节早期或情绪波动后，证见颈部结块、质地柔软、胸闷胁痛、情绪抑郁、喜叹息、舌淡红苔薄白、脉弦。治以疏肝理气、解郁散结，方选柴胡疏肝散合消瘰丸加减。常用药：柴胡、白芍、枳壳疏肝理气；香附、郁金解郁散结；浙贝母、玄参、牡蛎化痰软坚；夏枯草、连翘清肝散结。

痰瘀互结证：病程较长，结节增大、质地较硬，或伴疼痛、吞咽不适、舌暗或有瘀点、苔白腻、脉弦滑。治以化痰活血、软坚散结，兼调肝肾。方选海藻玉壶汤合桃红四物汤加减。常用药：海藻、昆布、贝母化痰软坚；当归、川芎、桃仁、红花活血化瘀；柴胡、郁金疏肝理气；生地黄、枸杞子滋肾养肝。

肝肾亏虚证：多见于中老年患者或结节久延不愈，证见结节质韧、头晕耳鸣、腰膝酸软、神疲乏力、舌淡红苔薄、脉沉细。治以滋补肝肾、软坚散结，方选左归丸合一贯煎加减。常用药：熟地黄、山茱萸、枸杞子、菟丝子滋补肝肾；当归、白芍养血柔肝；沙参、麦冬养阴生津；牡蛎、鳖甲软坚散结；夏枯草、浙贝母清肝散结。

张进军活用“调肝三十二字法”论治甲状腺结节，主张从肝论治，但强调疏肝不忘养血，养肝必及滋肾，通过运用逍遥散、一贯煎等方，使肝体得养、肝用得调，结节自消。

4.3 常用中药的肝肾调节作用分析

基于肝肾同源理论治疗甲状腺疾病，常用药物可按其作用特点归纳如下：

滋肾养肝类：生地黄、熟地黄、山茱萸、枸杞子、女贞子、墨旱莲、桑椹、龟板、鳖甲。此类药物填精养血，为肝肾阴虚证的主药。甲亢之阴虚阳亢、桥本后期之精血两虚、结节久延之肝肾亏虚，均可选用。

温肾助阳类：附子、肉桂、鹿角胶、肉苁蓉、巴戟天、淫羊藿、补骨脂。此类药物温补肾阳，用于甲减之肾阳虚衰、桥本后期之脾肾阳虚。使用时常配滋阴之品，取“阴中求阳”之意。

养血柔肝类：当归、白芍、熟地黄、何首乌、阿胶。此类药物补肝血、养肝体，用于甲减之肝血亏虚、甲亢之阴血不足、结节之肝郁血虚。

疏肝理气类：柴胡、白芍、枳壳、香附、郁金、青皮。此类药物调肝气、解肝郁，用于甲状腺疾病各阶段伴有气机郁滞者，尤以结节初期、桥本早期多用。

清肝泻火类：龙胆草、栀子、黄芩、夏枯草、牡丹皮。此类药物清肝经之火，用于甲亢之肝火亢盛、桥本早期之肝郁化火。

平肝潜阳类：牡蛎、龙骨、石决明、钩藤、天麻。此类药物潜降肝阳，用于甲亢之肝阳上亢、头晕目眩、心悸手颤。

化痰散结类：浙贝母、玄参、牡蛎、海藻、昆布、夏枯草、连翘。此类药物化痰软坚、散结消瘿，用于甲状腺结节、桥本甲状腺炎之甲状腺肿大。

活血化瘀类：桃仁、红花、川芎、丹参、莪术、三棱。此类药物活血通络、化瘀消癥，用于结节质地坚硬、病程久延者。

4.4 处方用药规律与组方思路

基于肝肾同源理论治疗甲状腺疾病，组方用药应遵循以下思路：

滋阴不忘助阳，补阳兼顾填精。肝肾阴阳互根互用，组方当体现阴阳互济之法。如治疗甲减之肾阳虚衰，右归丸中用熟地黄、山茱萸、枸杞子滋肾填精，使阳得阴助；治疗甲亢之阴虚阳亢，左归丸中用鹿角胶、菟丝子温润助阳，使阴得阳升。

养血必先填精，填精赖于养血。精血同源决定了补血与填精相辅相成。四物汤与左归丸合用，八珍汤与右归丸配伍，均取精血互生之意。桥本后期之精血两虚证，尤当重视精血同补。

疏肝当顾肝体，理气莫忘养肝。肝体阴用阳，疏肝理气之品多辛燥耗阴，使用时常配白芍、当归、生地黄等养血柔肝之品，使疏泄而不伤肝体。此即“疏肝不忘养肝”之意。

散结需调气血，消癥必顾正气。结节类病变虽以化痰活血、软坚散结为治，但久用攻伐之品易耗伤气血，损伤肝肾。组方时应适当加入黄芪、党参、当归、熟地黄等益气养血之品，使祛邪而不伤正。

分期动态论治，方随证转。桥本甲状腺炎病程长、证型变，治疗应随证立法、随法选方。柳红芳教授强调早期以清泻为主，后期以补益为主，联合外治、调摄情志、指导饮食，取得显著疗效。

---

5 典型病例分析

5.1 甲亢验案（水不涵木、肝阳上亢证）

患者情况：张某，女，32 岁，2021 年 3 月初诊。主诉：心悸手颤、烦躁易怒 3 月余。患者 3 月前因工作压力大，出现心慌、手颤、烦躁易怒、多食易饥、体重下降（3 月减轻 5kg）。查甲状腺功能：FT3 12.5pmol/L（↑），FT4

38.6pmol/L（↑），TSH <0.01mIU/L（↓）。甲状腺 B 超：甲状腺弥漫性肿大，血流丰富。诊断为甲状腺功能亢进症。患者拒绝西药治疗，求治于中医。

刻诊：心悸阵作，手颤明显，烦躁易怒，失眠多梦，头晕目眩，口干咽燥，腰膝酸软，月经量少，舌红少苔，脉弦细数。辨证为水不涵木、肝阳上亢证（肝肾阴虚，肝阳上亢）。

治法：滋水涵木，平肝潜阳。

方药：一贯煎合镇肝熄风汤加减。生地黄 20g，熟地黄 15g，枸杞子 15g，沙参 15g，麦冬 15g，当归 12g，白芍 15g，龟板 15g（先煎），鳖甲 15g（先煎），牡蛎 30g（先煎），钩藤 15g（后下），天麻 10g，夏枯草 15g，甘草 6g。14 剂，每日 1 剂，水煎服。

二诊：服药后心悸、手颤减轻，烦躁好转，仍失眠、口干。守方加酸枣仁 15g、五味子 10g 养心安神。继服 14 剂。

三诊：诸症明显好转，心悸基本消失，手颤轻微，情绪平稳，睡眠改善。复查甲状腺功能：FT3 6.8pmol/L，FT4 19.2pmol/L，TSH 0.15mIU/L。守方去钩藤、天麻，加山药 15g、山茱萸 12g 调补肝肾。继服 21 剂。

四诊：症状基本消失，月经正常，复查甲状腺功能正常。嘱服六味地黄丸善后，随访半年未复发。

按语：本案为典型甲亢，辨证抓住“腰膝酸软、月经量少、舌红少苔、脉细数”等肝肾阴虚之象，及“烦躁易怒、手颤、头晕目眩”等肝阳上亢之征，确立滋水

涵木、平肝潜阳之法。方中生地、熟地、枸杞子滋肾填精为君；沙参、麦冬养阴生津为臣；龟板、鳖甲、牡蛎滋阴潜阳，钩藤、天麻平肝熄风，当归、白芍养血柔肝，夏枯草清肝散结，共为佐使。全方滋肾养肝、平肝潜阳，使水充木荣、阳潜风息，诸症向愈。

5.2 桥本甲状腺炎验案（从阴虚阳亢到精血两虚的动态演变）

患者情况：李某，女，45 岁，2020 年 9 月初诊。主诉：颈前肿大伴乏力 1 年。患者 1 年前因情志不畅出现颈前肿大，伴烦躁、心悸，当地医院查甲状腺功能：FT3、FT4 轻度升高，TSH 降低，甲状腺自身抗体 TPOAb、TgAb 显著升高，诊断为桥本甲状腺炎甲亢期。予甲巯咪唑治疗，症状缓解但停药后复发。半年前转为甲减，出现畏寒、乏力、水肿，予左甲状腺素钠片（优甲乐）25μg/d 替代治疗，症状改善不明显，遂求中医诊治。

刻诊：神疲乏力，畏寒肢冷，面浮肢肿，腰膝酸软，记忆力减退，情绪低落，颈前肿大，质地韧，无压痛，舌淡胖边有齿痕，苔白，脉沉细。查甲状腺功能（服用优甲乐状态下）：FT3 3.2pmol/L，FT4 11.5pmol/L，TSH 8.6mIU/L（↑）。甲状腺 B 超：甲状腺弥漫性病变，考虑桥本甲状腺炎。辨证为脾肾阳虚、精血两虚证（疾病后期，阴损及阳）。

治法：温肾助阳，滋阴养血，扶正固本。

方药：右归丸合八珍汤加减。熟地黄 20g，山茱萸 15g，枸杞子 15g，菟丝子 15g，鹿角胶 10g（烊化），附子 10g（先煎），肉桂 6g，当归 12g，白芍

15g，川芎 10g，党参 15g，茯苓 15g，白术 15g，黄芪 20g，阿胶 10g（烊化），甘草 6g。21 剂，每日 1 剂，水煎服。优甲乐维持原量。

二诊：服药后乏力、畏寒减轻，水肿稍退。守方继服 21 剂。

三诊：精神状态明显改善，畏寒基本消失，水肿消退，记忆力好转。复查甲状腺功能：FT3 4.8pmol/L，FT4 16.2pmol/L，TSH 3.2mIU/L。优甲乐减量至 12.5μg/d，中药守方去附子、肉桂，加山药 15g、杜仲 12g 调补脾肾。

四诊：症状基本消失，甲状腺功能正常，TPOAb、TgAb 较前下降。嘱服右归丸合归脾丸善后，优甲乐维持 12.5μg/d。随访 1 年，病情稳定。

按语：本案完整呈现桥本甲状腺炎从甲亢期到甲减期的动态演变，体现“阴损及阳、精血两虚”的病机特点。后期以脾肾阳虚为本，精血亏虚为标。方用右归丸温补肾阳、填精益髓；八珍汤合黄芪、阿胶益气养血；使阳得阴助、生化无穷，血得气养、精血互生。治疗过程坚持病证结合，中药与优甲乐协同使用，既改善症状，又调节免疫功能，体现了中医药治疗自身免疫性甲状腺疾病的优势。

5.3 甲状腺结节验案（肝肾亏虚、痰瘀互结证）

患者情况：王某，女，52 岁，2022 年 6 月初诊。主诉：发现甲状腺结节 2 年，增大 1 月。患者 2 年前体检发现甲状腺右叶结节，大小约 0.8cm×0.6cm，TI-RADS 3 类，未特殊处理。1 月前复查 B 超示结节增大至 1.5cm×1.2cm，TI-RADS 4a 类，建议穿刺活检，患者拒绝，求治于中医。

刻诊：颈部右侧可及结节，质地偏硬，活动可，无压痛，伴咽部异物感，情绪抑郁，胸闷太息，头晕耳鸣，腰膝酸软，夜尿频多，舌暗红边有瘀点，苔白腻，脉弦细涩。辨证为肝肾亏虚、痰瘀互结证。

治法：滋补肝肾，化痰活血，软坚散结。

方药：左归丸合消瘰丸加减。熟地黄 20g，山茱萸 15g，枸杞子 15g，菟丝子 15g，浙贝母 15g，玄参 15g，牡蛎 30g（先煎），夏枯草 15g，当归 12g，川芎 10g，桃仁 10g，红花 6g，海藻 15g，昆布 15g，甘草 6g。21 剂，每日 1 剂，水煎服。

二诊：服药后咽部异物感减轻，情绪好转，结节未及明显变化。守方加莪术 10g、三棱 10g 增强活血散结之力。继服 21 剂。

三诊：结节较前变软，体积略缩小，头晕耳鸣、腰膝酸软好转。复查 B 超：结节 1.2cm×1.0cm，TI-RADS 3 类。守方去桃仁、红花，加山药 15g、杜仲 12g 调补肝肾。继服 21 剂。

四诊：结节进一步缩小至 0.8cm×0.6cm，症状基本消失。嘱服左归丸合消瘰丸（改丸剂）善后。随访半年，结节稳定。

按语：本案患者年过五旬，天癸已竭，肝肾亏虚为本；气滞痰凝血瘀为标，日久互结而成结节。治疗以左归丸滋补肝肾、填精益髓；消瘰丸合海藻、昆布化痰软坚；当归、川芎、桃仁、红花活血化瘀；夏枯草清肝散结。全方标本兼顾、攻补兼施，使精血得充、痰瘀得化、结节得消。体现了“治病求本”“扶正祛邪”的治疗原则。

6 讨论

6.1 肝肾同源理论的临床价值与意义

肝肾同源理论源于《内经》，历经数千年发展，已成为中医学脏腑相关理论的核心内容之一。本文将其应用于甲状腺疾病的诊疗实践，具有以下几方面的理论价值和临床意义：

首先，肝肾同源理论为认识甲状腺疾病提供了整体性视角。甲状腺虽为单一腺体，但其功能活动与全身多系统密切相关。从肝肾角度审视，甲亢不仅是甲状腺激素分泌过多，更是肝肾阴阳失衡的整体表现；甲减不仅是甲状腺激素不足，更是肾阳虚衰、肝血亏虚的综合反映。这种整体性认识有助于克服“见病不见人”“治局部不治整体”的局限。

其次，肝肾同源理论为甲状腺疾病的动态演变规律提供了合理解读。桥本甲状腺炎从甲亢期到甲减期的演变，与“阴虚→阴损及阳→阴阳两虚”的转化规律高度吻合。柳红芳教授提出的早期“水不涵木、肝阳上亢”到后期“阴损及阳、精血两虚”的病机认识，正是基于肝肾同源理论对 HT 动态演变规律的深刻把握。

再次，肝肾同源理论为治疗甲状腺疾病提供了明确的治则治法。滋水涵木法治疗甲亢、温肾助阳法治疗甲减、滋补肝肾法治疗结节，均以调节肝肾阴阳为核心，体现了治病求本的精神。临床实践证明，基于肝肾同源理论的辨证论治，在改善症状、调节免疫、降低复发率等方面具有独特优势。

6.2 现代诠释的尝试与反思

本文尝试在保持中医理论特质的前提下，将“肾”诠释为生长发育及血液化生相关激素的总调节器，将“肝”诠释为血液调节与内环境稳态的调节器。这一诠释旨在搭建传统理论与现代医学的对话桥梁，促进中西医学术交流。

从积极方面看，这种诠释有助于揭示肝肾同源理论的现代生物学基础。下丘脑-垂体-甲状腺轴与肝代谢功能的相互影响、神经-内分泌-免疫网络的多重联系，为“肝肾相关”提供了现代科学证据。滋水涵木法治疗甲亢的机制研究——如调节代谢紊乱、降低炎症水平、提高免疫功能等——初步揭示了其作用机理。

然而必须认识到，中医的“肝”“肾”是功能性概念，不能简单还原为解剖学意义上的肝脏和肾脏。肝藏血、主疏泄的功能涉及神经、内分泌、免疫、循环等多个系统的整合作用；肾藏精、主生长化收藏的功能涵盖神经内分泌调控、能量代谢、生殖发育等多个层面。本文的诠释只是一种尝试性探索，旨在促进理解，而非替代传统理论。

6.3 研究不足与展望

本研究存在以下不足之处：一是理论探讨较多，临床循证证据相对不足；二是对肝肾同源理论的现代诠释尚属初步尝试，有待进一步完善；三是对不同类型甲状腺疾病的分型论治，缺乏大样本临床研究的验证。

未来研究可从以下方向深入：一是开展基于肝肾同源理论治疗甲状腺疾病的临床研究，采用随机对照设计，提供高质量的循证证据；二是深入探讨滋水涵木、

温肾助阳等治法的作用机制，运用现代组学技术揭示其分子基础；三是开展肝肾同源理论的跨文化对话，促进中医理论走向世界；四是开发基于肝肾同源理论的系列方药，形成标准化治疗方案，便于临床推广应用。

---

7 结语

肝肾同源理论以精血同源、阴阳互根为核心内涵，深刻揭示了肝肾两脏在生理上的相互依存、在病理上的相互影响。甲状腺疾病作为常见内分泌疾病，其发生发展与肝肾阴阳失衡密切相关：甲亢以阴虚阳亢、水不涵木为主，甲减以阳虚精亏、精血两虚为主，桥本甲状腺炎呈现从肝郁火旺到阴虚阳亢再到精血两虚的动态演变，甲状腺结节则气痰瘀互结于颈前而其根本在肝肾。基于肝肾同源理论的诊疗策略，以燮理肝肾、调和阴阳为基本原则，通过滋水涵木、温肾助阳、养血疏肝、化痰散结等法，使用精血互生、阴阳互济，恢复甲状腺的正常功能。临床实践证明，这一思路在改善症状、调节免疫、降低复发率等方面具有独特优势。未来应进一步加强理论研究和临床验证，使肝肾同源理论在甲状腺疾病防治中发挥更大作用。

参考文献

[1] 董昭熙，柳红芳，宿家铭，等．柳红芳从"乙癸同源"论治桥本甲状腺炎经验[J]．中医药导报, 2022, 28(12).

[2] 张毅，赵丹丹，李小可，等．肝脾肾同调理论在甲状腺结节诊疗中的运用[J]．世界中医药, 2016(01).

[3] 王丽娜，田硕，王芙蓉．滋水涵木法治疗甲状腺功能亢进症的理论溯源与研究进展[J]．中国中医基础医学杂志, 2024, 30(5).

[4] 张芳，田丽，张珊珊．张珊珊基于"五脏相关"从肝脾肾立论桥本甲状腺炎[J]．现代中西医结合杂志, 2022(22).

[5] 从肝、脾、肾论治桥本氏甲状腺炎的理论探讨及临床运用分析[J]．贵州中医药大学学报, 2021(2): 6-9.

[6] 论桥本甲状腺炎当从肝、脾、肾三脏论治[J]．北京中医, 2007(12).

[7] 陈如泉从肝脾肾论治桥本甲状腺炎合并甲减的经验[J]．中国民族民间医药, 2024, 33(2): 85-88.

[8] 谈滋水涵木扶土论治桥本氏病[J]．光明中医, 2022(15): 2728-2730.

[9] 张进军活用"调肝三十二字法"论治甲状腺结节[J]．中医药临床杂志, 2022(12): 2293-2297.

[10] 王冰梅，张子默，李敬孝，等．从肝脾论治桥本甲状腺炎的思路探析[J]．中医药学报, 2022(6): 9-11.